# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81784
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-04-02 12:24:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | : ENODINA DEL CARMEN GUTIERREZ MARIN | | | **RUN** | : 7.806.150-2 |
| **F.Nac** | : 13-10-1946 | **Edad** | : 77 AÑOS, 5 MESES | **Género** | : Femenino |
| **Dirección** | : TEGUALDA 997 PB. ARAUCANIA | | | **Comuna** | : SAN CARLOS |
| **Previsión** | : FONASA B | **Teléfono** | : 99053308 | | |
| **Fecha Ingreso** | : 2024-03-19 | **Fecha Egreso** | : 2024-04-02 12:24:00 | **Causal** | : MEDICA |
| **Condición** | : VIVO | **Destino** | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | **Derivación** | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda Global Hipercápnica
1.1 EPOC exacerbado por proceso infeccioso
1.2 SAHOS
2. Neumonía basal derecha tratada
3. ICC descompensada FEVIc (ecocardio 2021)
4. Antecedentes: Obesidad mórbida, HTA, Semi-dependiente

Procedimiento Invasivo UTI: Linea arterial, VMNI ( 45 hrs)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G47.3-APNEA DEL SUENO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 77 años semidependiente , con antecedentes descritos, consulta en servicio de urgencias del HSC el 19/03/2024 por dificultad respiratoria, somnolencia y dolor abdominal. Al control de signos vitales PA 125/89; FC 85 lpm, T 36.1, FR 27 rpm, Sat O2 70%. Examenes de laboratorio evidencia acidosis respiratorio con PCO2 de hasta 94.1, PO2 71.6, PCR levemente aumentada, función renal conservada sin alteraciones hidroelectoliticas. Se solicita TC de tórax sin contraste que informa "foco de consolidación en base pulmonar derecha y atelectasias subsegmentarias en lóbulos inferiores". Se apoya con O2 por naricera, se instala sonda Foley (se solicitan UC + OC) y se administra furosemida 20 mg ev, hidrocotrisona 300 mg ev, más broncodilatadores. Evaluada por Residente UTI, paciente con acidosis respiratoria hipercapnia beneficiaria de VMNI por lo que se decide ingreso a unidad. A su ingreso paciente obnubilada, desorientada TE, con llene capilar menor a 2 segundos, con crepitos bibasales, sin uso de musculatura accesoria, sin edema de EEII. Se instala VMNI, control de GSA a las 2 hrs evidencia mala evolución gasométrica a pesar de correcto seteo de VNI, empeora en ciclo de sueño GSA Ph 7.16 / PCO2 104 / PO2 76, por lo que se presenta a residente UCI, y traslada a dicha unidad. Se mantiene apoyada con VMNI, el 21/03/24 se inician ventanas de alimentación apoyada con NRC,

ultima conexión a VMNI el 21/03/24 durante la noche, manteniendo aporte de FiO2 por NRC. Completa tratamiento con Ceftriaxona durante 3 días, con posterior traslape a Amoxicilina/Acido Clavulánico completando en total 7 días de tratamiento antibiótico. Sin conflicto renal ni metabólico durante estadía en UCI. El 27/03/24 se traslada nuevamente a UTI, GSA de ingreso mantiene pCO2 >65 por lo que se decide nuevamente apoyo de VMNI solo nocturno en modo ST, con apoyo diurno de FiO2 bajas (máximo 24%), logrando valores basales de paciente pCo2 cercanas a 50. Apoyada con rehabilitación kinesica motora y respiratoria, más broncodilatadores de uso crónico. Evaluada por Broncopulmonar el 28/03 y 01/04, se plantea aporte de FiO2 bajo por NRC diurno, VMNI nocturno, control con GSA diario más informe de habitabilidad con Asistente Social de APS para evaluar factibilidad de VMNI en domicilio. Considerando tiempo de espera para dicho informe, se solicita evaluación preliminar con Asistente Social de HSC.
Actualmente paciente estable, en buenas condiciones generales, hemodinamia autosostenida, ventilando espontáneo apoyada con FiO2 24% NRC, sin conflicto infeccioso, renal ni metabólico. Se decide HODOM con O2 domiciliario (aceptado), continuar rehabilitación con Kinesiología tanto motora como respiratoria, control con GSA en dos semanas y control con Broncopulmonar Hospital de San Carlos en 15 a 30 dias.

## PLAN DE MANEJO:

HODOM
O2 por NRC 0.5 a 1 lt/min
Control GSA en 2 semanas
Evaluación por Asistente Social de Cesfam --> Informe habitabilidad
Control con Broncopulmonar Hospital de San Carlos en 15 a 30 dias.

## INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo asistido
2. Regimen liviano hiposódico
3. FiO2 para SatO2 >88-90% (0.5 a 1 lt/min)
4. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al día vo
5. Furosemida 40 mg c/12 h vo
6. Losartan 50 mg 1/2 comp c/12 h vo
7. Tiotropio 2 puff cada 24 hrs
8. Fluticasona/Salmeterol (25/250 mcg) 2 puff cada 12 hrs con aerocámara
9. Salbutamol 2 puff cada 4 hrs con aerocámara
10. Bromuro de Ipratropio 2 puff cada 6 hrs con aerocámara

## EXÁMENES Y RESULTADOS

02/04/24: GSA pH 7.43, pO2 77, pCO2 52, HCO3 35
30/03/24: Crea 0.7. PCR 18, ELP 135/4.1/93, Leuco 5700, Hcto 43, Hb 14.3, INR 1, Ph 7.44, PCO2 44, PO2 77.9, PAFI 3
29/03/2024: Crea 0.6, PCR 24.4, Uremia 61, ELP 135/4.2/92, Leuco 5.800, Hcto 44.1, Hb 14.4, Plaquetas 143, GSA Ph 7.49, PCO2 61.2, PO2 80.9, HCO3 46.5, Sat 96.
TC 19/03/24: foco condensación basal derecho. Atelectasias subsegmentarias lóbulos inferiores. Cambios inflamatorios crónicos en pared bronquial. Enfermedad ateromatosa aorta torácica, válvula aórtica y coronarias.

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO